

# Humor jako mechanizm obronny u pacjentów, terapeutów i w relacjach społecznych

## Streszczenie

W ścisłym sensie psychodynamicznym **humor** jest klasycznym **dojrzałym mechanizmem obronnym** wtedy, gdy pozwala osobie uznać bolesną rzeczywistość, zachować testowanie rzeczywistości i jednocześnie zmienić sposób odnoszenia się do cierpienia. Z tej perspektywy **najbliżej mu do stylu self-enhancing**, czyli „humoru w służbie ego”; **humor afiliacyjny** jest zwykle adaptacyjny, ale częściej pełni funkcję społeczną niż obronną sensu stricto; natomiast **humor agresywny** i **self-defeating** częściej wiążą się z obronami mniej dojrzałymi, takimi jak dewaluacja, acting out, przemieszczenie czy obronna samodeprecjacja nastawiona na utrzymanie akceptacji innych (Vaillant, 2000; Andrews i in., 1989; Hornowska i Charytonik, 2011). [1]

Stan badań empirycznych jest **obietujący, ale metodologicznie nierówny**. Najlepszy przegląd prac klinicznych wykazał, że w psychoterapii dorosłych badań kwalifikujących się do syntezy było niewiele i były one bardzo heterogeniczne: obejmowały łącznie zaledwie 10 prac, w tym 4 RCT, 3 badania quasi-eksperymentalne, 1 badanie korelacyjne i 2 przeglądy systematyczne. Wyniki sugerują, że interwencje humorystyczne *mogą* redukować objawy depresji i lęku, ale nie zawsze przewyższają warunki aktywnej kontroli, a część efektów jest krótkotrwała lub zależna od populacji klinicznej oraz sposobu operacjonalizacji humoru (Sarink i García-Montes, 2023). [2]

W samym procesie terapii humor i śmiech są **częste**, lecz niejednoznaczne.

W badaniach sesyjnych banter/humor odnotowano w 62 z 68 sesji pacjentów z depresją, a w psychodynamicznej psychoterapii dorosłych zarejestrowano 814 epizodów śmiechu klienta w 330 sesjach, średnio około jednego epizodu na sesję. Wspólny śmiech pacjenta i terapeuty wiązał się z większą zmianą przewodnictwa skórniego niż śmiech samotny, a „facylitujący” banter korelował z komponentem bondu przymierza terapeutycznego. Jednocześnie śmiech był także regulacją napięcia, dystansowaniem się lub przykrywaniem wstydu i podatności na zranienie (Marci i in., 2004; Gupta i in., 2018; Brooks i in., 2023; Hoff i Strømme, 2025). [3]

Najbardziej praktyczny wniosek kliniczny brzmi więc nie „humor pomaga”, lecz raczej: **pomaga określony rodzaj humoru, u części osób, w określonym momencie, przy odpowiednim poziomie przymierza i dostrojeniu terapeuty**. Humor warto wzmacniać wtedy, gdy zwiększa dystans poznawczy bez odcinania afektu; przekierowywać, gdy staje się ucieczką od emocji; i interpretować/adresować wprost, gdy przyjmuje formę agresji, samoupokorzenia, dewaluacji albo niewerbalnego sygnału pęknięcia relacji. To wniosek spójny z wynikami badań naturalistycznych, pracami z obszaru regulacji emocji i z klasycznymi ostrzeżeniami przed „ukrytą wrogością” terapeutycznego humoru (Kubie, 1970; Sarink i García-Montes, 2023; Perchtold i in., 2019; Hoff i Strømme, 2025). [4]

## Zakres i założenia

Ponieważ nie wskazano specyficznej populacji klinicznej, raport przyjmuje jako **główny punkt odniesienia dorosłych pacjentów ambulatoryjnych w psychoterapii indywidualnej**, a wyniki z depresji, schizofrenii, settingów szkoleniowych, poradnictwa internetowego/metaverse oraz badań analogowych na studentach traktuje jako materiał uzupełniający. Rozróżniam też trzy pokrewne, ale nieidentyczne konstrukty: **humor** jako proces poznawczo-emocjonalno-społeczny, **śmiech** jako ekspresję wokarno-behawioralną, oraz **banter/przekomarzanie** jako szczególną formę humoru interpersonalnego. To rozróżnienie jest konieczne, bo nie każdy śmiech oznacza rozbawienie, a w terapii śmiech może sygnalizować także lęk, zakłopotanie, ambiwalencję lub dystansowanie się (Sarink i García-Montes, 2023; Gupta i in., 2018; Kang i in., 2024). [5]

W relacjach codziennych humor najlepiej rozumieć jako **narzędzie komunikacyjne i sygnał interpersonalny**, natomiast w psychoterapii trzeba dodać jeszcze perspektywę **mechanizmów obronnych, asymetrii ról i funkcji klinicznych**. Oznacza to, że nie każdy „dobry żart” w życiu społecznym będzie klinicznie użyteczny, a nie każdy epizod śmiechu w terapii jest oznaką postępu. Humor jest w terapii narzędziem precyzyjnym, a nie domyślnie „prozdrowotnym” dodatkiem (Meyer, 2000; Zeigler-Hill i in., 2013; Sarink i García-Montes, 2023). [6]

## Definicje i ramy teoretyczne

### Ujęcie psychodynamiczne

W tradycji psychodynamicznej mechanizmy obronne są rozumiane jako automatyczne, zwykle nieświadome procesy chroniące przed przeciążeniem afektywnym i konfliktem wewnętrznym. Vaillant zaliczył **humor** do obron dojrzałych, obok m.in. sublimacji, supresji i antycypacji, a późniejsze narzędzia samoopisowe i obserwacyjne, takie jak **DSQ** i **DMRS/DMRS-Q**, utrzymały tę pozycję humoru na wysokim poziomie adaptacji. Jednocześnie klasyczna literatura ostrzega, że humor może mieć postać destrukcyjną, gdy służy ukrytej wrogości, dewaluacji lub przerwaniu „strumienia uczucia i myślenia” pacjenta (Vaillant, 2000; Andrews i in., 1989; Di Giuseppe i in., 2021; Kubie, 1970). [7]

Ważne doprecyzowanie daje literatura kliniczna wskazująca, że **humor staje się mechanizmem obronnym sensu stricto przede wszystkim wtedy, gdy jest stosowany wobec własnej sytuacji podmiotu**, a nie wtedy, gdy jest jedynie agresją wobec innych. To rozróżnienie jest bardzo użyteczne w terapii: autoironia może być dojrzałym dystansem, ale może też być obronną samodeprecjacją; z kolei szyderstwo wobec innych bywa mniej „humorem”, a bardziej przebranym atakiem (Bellone i in., 2005; Vaillant, 2000; Hornowska i Charytonik, 2011). [8]

### Ujęcie poznawczo-behawioralne

W tradycji poznawczo-behawioralnej humor jest najczęściej rozumiany jako **forma przewartościowania poznawczego**, która może obniżyć katastrofizację, osłabiać

nadmierną powagę poznawczą i zwiększać elastyczność psychologiczną. Ellis jawnie opisywał używanie humorystycznych kontrprzesad do podważania irracjonalnych przekonań, a współczesne badania nad **humorous reappraisal** pokazują, że humor łagodny/życzliwy jest powiązany z bardziej adaptacyjnymi strategiami poznawczej reinterpretacji niż humor „ciemny” lub wrogi (Ellis, 1977; Sarink i García-Montes, 2023; Perchtold i in., 2019). [9]

Eksperymentalnie wykazano, że **humorous coping** przynosi korzystne efekty zarówno krótkoterminowo, jak i dłużej po ekspozycji na bodźce negatywne: w jednym z najlepiej zaprojektowanych eksperymentów 57 uczestników używających humorystycznego radzenia sobie uzyskało większy wzrost emocji pozytywnych i większy spadek emocji negatywnych niż osoby stosujące „poważne” przewartościowanie. To wspiera kliniczną tezę, że dobrze użyty humor nie jest tylko unikaniem, ale może być specyficznym trybem restrukturyzacji znaczenia (Samson i in., 2014). [10]

## Ujęcie interpersonalne

Z perspektywy interpersonalnej humor jest „**mieczem obosiecznym**”: może jednoczyć przez identyfikację i doprecyzowanie wspólnego znaczenia, ale może też dzielić przez egzekwowanie norm i różnicowanie „nas” od „nich”. W psychoterapii odpowiada to napięciu między humorem budującym przymierze a humorem, który ustanawia przewagę, zawstydzia albo odsuwa od emocjonalnej bliskości (Meyer, 2000). [11]

Badania naturalistyczne dobrze ilustrują tę wielofunkcyjność. W analizie sesji poznawczych terapeuci odpowiadali na humor pacjenta poprzez **aligning**, **disaligning** lub strategie mieszane, zaś humor inicjowany przez terapeutę przyjmował rozmaite formy interakcyjne i był przez pacjentów wspierany śmiechem. W badaniu banteru u 68 pacjentów z depresją facylitacyjne przekomarzanie korelowało z „bond”, a jakościowa analiza ujęcia niewerbalnego pokazała, że śmiech i uśmiech mogą jednocześnie wzmacniać więź, regulować dystans, maskować podatność na zranienie i sygnalizować momenty wymagające containmentu (Dionigi i Canestrari, 2018; Brooks i in., 2023; Hoff i Strømme, 2025). [12]

## Ujęcie neurobiologiczne

Neurobiologicznie humor łączy **wykrywanie niespójności**, jej „**bezpieczne**” rozwiązanie i **aktywację układu nagrody**. Badania neuroobrazowe wskazują na udział struktur mezolimbicznych i prążkowiec brzuszny w doświadczaniu rozbawienia, a prace nad różnymi typami humoru sugerują, że humor łagodny i szkodliwy mają odmienne wzorce sprzężeń sieciowych: dla humoru łagodnego istotny jest m.in. nucleus accumbens, dla humoru szkodliwego silniej zaznacza się udział torów amygdala–kora czołowa. Z kolei metaanaliza interwencji opartych o śmiech wykazała redukcję poziomu kortyzolu, szczególnie dla śmiechu spontanicznego (Berns, 2004; Chan i in., 2018; Kramer i in., 2023). [13]

Neurobiologia wspiera więc ostrożną tezę kliniczną: humor może jednocześnie **zmieniać appraisal**, **przynosić fizjologiczną ulgę** i **wzmacniać więź przez współregulację**,

ale tylko wtedy, gdy jest przeżywany jako bezpieczny i nieupokarzający. Co więcej, istnieją dane o różnicach płciowych na poziomie przetwarzania humoru, sugerujące przeciętnie większą reaktywność limbiczną u kobiet i bardziej ewaluacyjne przetwarzanie u mężczyzn; ich znaczenie kliniczne pozostaje jednak ograniczone i nie powinno być traktowane normatywnie (Kohn i in., 2011; Chan i in., 2016). [14]

Diagram poniżej jest **syntezą funkcji humoru w terapii** na podstawie badań nad obronami, przymierzem, śmiechem i reappraisalem. (Vaillant, 2000; Meyer, 2000; Marci i in., 2004; Brooks i in., 2023; Hoff i Strømme, 2025). [15]



## Typologia humoru i mapa na mechanizmy obronne

Najczęściej stosowaną taksonomią humoru jest model **2 × 2** Roda Martina, oparty na dwóch osiach: **adaptacyjność** oraz **funkcja interpersonalna vs intrapsychiczna**.

W polskiej adaptacji HSQ odpowiadają mu cztery style: **humor afiliacyjny**, **humor w służbie ego (self-enhancing)**, **humor agresywny** i **humor samodeprecjonujący (self-defeating)**. Polska literatura podkreśla, że tylko część tych stylów ma charakter jednoznacznie korzystny psychologicznie; równie ważne jak „ilość humoru” są cel, adresat i funkcja użycia humoru w codziennym życiu (Hornowska i Charytonik, 2011). [16]

W badaniach nad dobrostanem i zdrowiem psychicznym te cztery style rozszczepiają się regularnie na dwa profile. **Affiliative** i **self-enhancing** są dodatnio związane z dobrostanem, satysfakcją z relacji, empatią i niższym nasileniem objawów depresyjnych, natomiast **self-defeating** pokazuje stabilnie niekorzystne związki z dobrostanem i psychopatologią. **Aggressive humor** jest najbardziej niejednoznaczny: w szerokich metaanalitycznych wskaźnikach zdrowia psychicznego bywa słabo powiązany lub niespójny, ale dla relacji i dobrostanu subiektywnego zwykle działa

niekorzystnie, zwłaszcza w kontekstach konfliktu interpersonalnego (Schneider i in., 2018; Jiang i in., 2020; Hall, 2017; Winterheld i Simpson, 2013; Hampes, 2010). [17]

Poniższa tabela ma charakter **mapy roboczej**, a nie „oficjalnej” translacji HSQ na język mechanizmów obronnych. Jej główna teza jest prosta: **tylko self-enhancing humor odpowiada wprost klasycznemu dojrzałemu mechanizmowi obronnemu „humor”**, podczas gdy pozostałe style należy rozumieć raczej jako wzorce użycia humoru, które mogą współwystępować z określonymi obronami. (Vaillant, 2000; Bellone i in., 2005; Hornowska i Charytonik, 2011). [18]

| Typ humoru            | Najbliższy odpowiednik w języku obron                                                                                                  | Dominująca funkcja                                                 | Typowe wskaźniki kliniczne                                                                              | Ryzyko / potencjał                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affiliacyjny</b>   | Nie jest klasyczną obroną sensu stricto; zwykle współwystępuje z dojrzałymi obronami i zdolnością do afiliacji, supresji i antycypacji | Obniżenie napięcia, budowanie wspólnoty, osvajanie trudnych treści | Żart „z nami, nie z kogoś”; wzrost wzajemności; brak humilacji; pacjent pozostaje w kontakcie z afektem | Wysoki potencjał dla alliance-building; ryzyko banalizacji tylko przy złym timingu |
| <b>Self-enhancing</b> | Najbliższy klasycznemu dojrzałemu mechanizmowi <b>humor</b> ; często łączy się z antycypacją i realistycznym dystansem                 | Reappraisal, odporność, utrzymanie perspektywy pod stresem         | Pacjent potrafi nazwać ból i jednocześnie uchwycić absurd sytuacji bez zaprzeczania faktom              | Najbardziej obiecujący klinicznie; sprzyja regulacji emocji i elastyczności        |
| <b>Aggressive</b>     | Częściej zbieżny z dewaluacją, przemieszczeniem, acting out, bierną agresją lub projekcją niż z dojrzałym humorem                      | Dominacja, rozładowanie wrogości, egzekwowanie granic przez atak   | Sarkazm, kpinny ton, śmiech kosztem drugiej osoby, podminowywanie autorytetu lub relacji                | Ryzyko pęknięcia przymierza, wstydu i eskalacji konfliktu                          |
| <b>Self-defeating</b> | Samodewaluacja, „turning against the self”, obronne zaprzeczanie własnym uczuciom dla utrzymania akceptacji                            | Appeasement, regulacja wstydu, prewencja odrzucenia                | Nawracająca autoironia po ujawnieniu bólu; śmiech „przed” uczuciem; podporządkowujący styl relacyjny    | Może chwilowo ułatwiać kontakt, ale długofalowo utrwała wstyd i tłumienie potrzeb  |

**Źródła tabeli:** Vaillant (2000), Andrews i in. (1989), Hornowska i Charytonik (2011), Bellone i in. (2005), Schneider i in. (2018), Jiang i in. (2020). [19]

W codziennych relacjach społecznych ta mapa ma dodatkowe znaczenie. Humor działa tam jak **sygnał interpersonalny**: komunikuje status, gotowość do bliskości, normy grupowe, styl radzenia sobie ze stresem i sposób obchodzenia się z konfliktem. Meta-analiza relacji romantycznych wykazała, że humor dodatni jest powiązany z większą satysfakcją relacyjną, a badania nad konfliktem pokazują, że humor agresywny jest odbierany szczególnie negatywnie przez partnerów bardziej potrzebujących opieki i bezpieczeństwa. To ważne klinicznie, bo pacjent wnosi do

gabinetu właśnie taki utrwalony „humorystyczny styl relacyjny” (Hall, 2017; Winterheld i Simpson, 2013; Zeigler-Hill i in., 2013). [20]

## Dane empiryczne

Najpierw warto jasno powiedzieć, czego **nie wiemy**. Nie istnieje dziś uzgodniona epidemiologia „humoru jako mechanizmu obronnego” w psychoterapii. Badania używają różnych jednostek analizy: stylów humoru, epizodów śmiechu, banteru, terapii grupowej, interwencji humorystycznych, a nawet aktów fizjologicznej synchronii. Z tego powodu zamiast liczyć „prewalencję” w sensie epidemiologicznym, sensowniej mówić o **częstości występowania określonych form humoru w próbkach sesyjnych** oraz o **ich związkach z funkcjonowaniem**. W dostępnych danych humor/śmiech okazuje się raczej zjawiskiem częstym niż rzadkim, ale jego znaczenie zmienia się zależnie od typu humoru, momentu sesji i jakości relacji (Sarink i García-Montes, 2023; Gupta i in., 2018; Brooks i in., 2023). [21]

W wąsko rozumianej psychoterapii indywidualnej najważniejsze jest rozróżnienie między **krótkoterminowymi funkcjami procesowymi** a **długoterminowym wynikiem leczenia**. Dane procesowe są dość spójne: humor może budować sojusz, obniżać napięcie i tworzyć bezpieczny dystans poznawczy. Dane wynikowe są słabsze: część prac pokazuje poprawę objawową, ale próby są małe, interwencje niejednorodne, a aktywne warunki kontrolne bywają równie skuteczne albo skuteczniejsze. Najmocniej potwierdzony jest zatem nie tyle „antydepresyjny efekt humoru” jako takiego, ile jego użyteczność jako **moderatora procesu terapeutycznego** (Sarink i García-Montes, 2023; Samson i in., 2014; Panichelli i in., 2018). [22]

## Zestawienie kluczowych badań

| Autorzy, rok      | Próba                                                       | Projekt                               | Miary / operacjonalizacja                                                      | Główne wyniki                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marci i in., 2004 | 10 diad psychodynamicznych                                  | Obserwacyjne, psychofizjologiczne     | Kodowanie śmiechu + przewodnictwo skórne                                       | Wspólny śmiech pacjenta i terapeuty wiązał się z większą zmianą SC niż śmiech samotny; wynik wspiera interpersonalną rolę śmiechu |
| Gupta i in., 2018 | 33 klientów, 16 terapeutów, 330 sesji, 814 epizodów śmiechu | Naturalistyczne, wielopoziomowe       | Kategorie śmiechu klienta: cheerful, polite, reflective, contemptuous, nervous | Śmiech klienta był częsty i wieloznaczny; nie był prostym markerem „postępu”, lecz nośnikiem funkcji relacyjnych i defensywnych   |
| Kang i in., 2024  | 159 sesji, 26 klientów                                      | Wielopoziomowe, session-level outcome | Kategorie śmiechu klienta + outcome sesyjny                                    | Na poziomie sesji śmiech cheerful i nervous dodatnio wiązał                                                                       |



| Autorzy, rok                        | Próba                                              | Projekt                                     | Miary / operacjonalizacja                                           | Główne wyniki                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panichelli i in., 2018</b>       | 110 dorosłych pacjentów ambulatoryjnych, 20–70 lat | Korelacyjne, retrospektywne kodowanie sesji | Humor w sesjach, Hamilton Depression Scale, CGI-2                   | Główne wyniki się z outcome sesyjnym; inne typy nie były istotne<br>Większa obecność humoru wiązała się z poprawą objawową; agresywnego humoru unikano, by chronić alliance |
| <b>Brooks i in., 2023</b>           | 68 pacjentów z depresją (PA, PD, CBT)              | Analiza wtórna sesji                        | KBI, alliance, outcome, positive introject                          | Banter stwierdzono w 62/68 sesji; facylitacyjny banter częściej występował w CBT i korelował z bond oraz positive introject                                                 |
| <b>Dionigi i Canestrari, 2018</b>   | 8 pierwszych sesji terapii poznawczej              | Analiza konwersacyjna                       | Humor inicjowany przez klienta lub terapeutę                        | Humor wchodził w różne sekwencje interakcyjne; odpowiedź terapeuty mogła wzmacniać lub modulować relację                                                                    |
| <b>Falkenberg i in., 2011</b>       | 6 pacjentów z depresją                             | Quasi-eksperymentalne, pilot                | Trening humoru McGhee, BDI, cheerfulness                            | Poprawiła się state/trait cheerfulness, ale długoterminowa poprawa w głównej skali depresji nie była istotna                                                                |
| <b>Cai i in., 2014</b>              | 30 pacjentów ze schizofrenią                       | RCT                                         | Interwencja humorystyczna, BDI (chińska), STAI                      | Humorystyczna interwencja obniżyła wyniki depresji i lęku; grupa kontrolna nie wykazała zmian                                                                               |
| <b>Gelkopf i in., 1993</b>          | 22 pacjentów ze schizofrenią                       | RCT                                         | Interwencja humorystyczna, BPRS total i subskala anxiety-depression | Istotna poprawa BPRS ogółem i w komponencie anxiety-depression                                                                                                              |
| <b>Sarink i García-Montes, 2023</b> | 10 badań z 7 krajów                                | Przegląd systematyczny                      | PRISMA, ocena jakości, synteza jakościowa                           | Dowody są obiecujące, ale nadal ograniczone przez małe próby, heterogeniczność i słabe operacjonalizacje humoru                                                             |

**Źródła tabeli:** Marci i in. (2004), Gupta i in. (2018), Kang i in. (2024), Dionigi i Canestrari (2018), Brooks i in. (2023), Sarink i García-Montes (2023). Dane o Falkenberg, Cai, Gelkopf i Panichelli pochodzą z przeglądu systematycznego Sarinka i García-Montes. [\[23\]](#)

## Funkcje humoru w terapii

Z punktu widzenia procesu psychoterapii cztery funkcje są najlepiej udokumentowane. Po pierwsze, **regulacja emocji**: humor może osłabiać katastrofizację i przynosić ulgę. Po drugie, **unikanie i dystansowanie**: ten sam śmiech może maskować wstyd, podatność na zranienie albo lęk. Po trzecie, **budowanie alliance**: wspólny lub życzliwy humor zwiększa poczucie „bycia zrozumianym”. Po czwarte, **zarządzanie granicami**: humor pomaga ustawić dystans interpersonalny, ale gdy jest źle użyty — także ten dystans nadmiernie powiększa (Samson i in., 2014; Marci i in., 2004; Brooks i in., 2023; Hoff i Strømme, 2025). [24]

Klinicznie kluczowa jest różnica między humorem **pacjenta** a humorem **terapeuty**. Humor pacjenta jest przede wszystkim **materiałem diagnostycznym i relacyjnym**: mówi coś o obronach, przywiązaniu, poziomie wstydu, gotowości do bliskości i tolerancji afektu. Humor terapeuty jest natomiast **interwencją** — z definicji obciążoną asymetrią władzy i ryzykiem etycznym. Badania z analizy niewerbalnej pokazują nawet, że terapeuci częściej **modulują i osłabiają** własną odpowiedź na śmiech klienta, niż po prostu go lustrzanie odwzorowują; jest to prawdopodobnie forma containmentu, a nie „brak poczucia humoru” (Dionigi i Canestrari, 2018; Hoff i Strømme, 2025). [25]

Jeśli chodzi o efekty **krótko- versus długoterminowe**, obraz jest asymetryczny. Krótkoterminowo humor częściej działa na korzyść: poprawia klimat sesji, zmniejsza napięcie, czasem podnosi outcome sesyjny. Długoterminowo dane są słabsze. Pilotowe programy treningu humoru w depresji poprawiały cheerfulness, ale nie dawały stabilnego efektu w głównej skali depresji; z drugiej strony niektóre RCT i badania korelacyjne wskazują na spadek objawów depresyjnych i lękowych. Najrozsądniejszy wniosek jest taki, że **humor sam w sobie rzadko jest samodzielny czynnikiem leczącym**, ale może wzmacniać działanie innych mechanizmów zmiany, takich jak reappraisal, więź, zaangażowanie i tolerancja pobudzenia (Falkenberg i in., 2011; Cai i in., 2014; Sarink i García-Montes, 2023). [26]

W relacjach codziennych baza dowodowa jest znacznie mocniejsza niż w psychoterapii. Meta-analiza relacji romantycznych wykazała związek pozytywnego humoru z satysfakcją ze związku, a badania nad humorem jako sygnałem interpersonalnym pokazują, że styl humoru komunikuje zarówno cechy osobowości, jak i oczekiwany sposób bycia w relacji. Z klinicznego punktu widzenia wspiera to tezę, że humor pacjenta w gabinecie nie jest „ozdobnikiem”, lecz skrótem do jego habitualnego stylu regulacji i bycia z innymi (Hall, 2017; Zeigler-Hill i in., 2013). [27]

## Moderatory, etyka i pomiar

### Moderatory kulturowe i płciowe

Kontekst kulturowy ma duże znaczenie dla tego, **co w ogóle jest rozpoznawane jako humor**, kto może żartować, z czego wolno żartować i kiedy żart jest oznaką ciepła, a kiedy naruszenia granic. Przeglądy międzykulturowe wskazują, że mieszkańcy Ameryki Północnej przeciętnie oceniają humor bardziej pozytywnie i częściej deklarują



jego używanie niż osoby z Azji Wschodniej, ale metaanaliza związku stylów humoru z dobrostanem nie wykazała stabilnej moderacji przez kulturę lub wiek na poziomie ogólnym. W praktyce klinicznej oznacza to, że **kontekst kulturowy jest ważniejszy dla interpretacji konkretnego epizodu humoru niż dla samego kierunku zależności adaptacyjny–nieadaptacyjny** (Jiang i in., 2019; Jiang i in., 2020; Lu i in., 2023). [28]

W danych płciowych najbardziej powtarzalny jest wzorzec mówiący, że **nieadaptacyjne style humoru są przeciętnie częstsze u mężczyzn**, podczas gdy dla stylów adaptacyjnych różnice bywają małe lub niespójne. Polska adaptacja HSQ również raportowała brak wyraźnych różnic płciowych dla stylów adaptacyjnych i większą typowość stylów nieadaptacyjnych u mężczyzn. Równocześnie badania neuroobrazowe sugerują przeciętne różnice płciowe w torach przetwarzania humoru, ale klinicznie nie powinny one prowadzić do sztywnych stereotypów — raczej do ostrożności interpretacyjnej i monitorowania indywidualnego znaczenia żartu dla konkretnego pacjenta (Hornowska i Charytonik, 2011; Kohn i in., 2011; Schneider i in., 2018). [29]

Szczególnie ważnym moderatorem klinicznym wydaje się **styl przywiązania**. Dane wskazują, że unikanie przywiązaniowe wiąże się częściej z dystansującym użyciem śmiechu i z większą skłonnością do stylów humoru samozaniżającego lub agresywnego, natomiast bezpieczniejsze przywiązanie sprzyja humorowi self-enhancing i afiliacyjnemu. To trafnie tłumaczy, dlaczego w terapii śmiech może jednocześnie „zblizać” i „oddalać”: to zależy od tego, czy jest on nośnikiem więzi, czy deaktywacji potrzeb przywiązaniowych (Dionigi i in., 2023; Hoff i Strømme, 2025). [30]

## Etyka i implikacje kliniczne

Najstarsze ostrzeżenia dotyczące humoru terapeutycznego pozostają aktualne. Humor może być źle użyty jako **ukryta wrogość**, narcystyczny pokaz błyskotliwości terapeuty, banalizacja cierpienia lub komunikat „twojego problemu nie trzeba brać aż tak serio”. Nowsze przeglądy nadal rekomendują ostrożność i podkreślają, że niewłaściwie użyty humor prowadzi do nieufności, zakłopotania i osłabienia przymierza (Kubie, 1970; Sarink i García-Montes, 2023; Kucharski, 2023; Vendl i in., 2024). [31]

Jednocześnie współczesne przeglądy mówią, że profesjonaliści zdrowia psychicznego używają humoru nie tylko wobec pacjentów, ale też jako **własnej strategii radzenia sobie ze stresem**, zasobu zespołowego i sposobu budowania relacji z użytkownikami usług. Problemem nie jest więc samo użycie humoru, lecz brak wystarczająco precyzyjnych danych, **jakiego humoru, kiedy i wobec kogo używać**. Ta luka badawcza jest dziś bardziej widoczna niż dawniej (Goodwin i in., 2024; Hussong i Micucci, 2021). [32]

## Metody oceny i narzędzia pomiarowe

W praktyce badawczej nie ma jednego „złotego standardu” do pomiaru humoru jako obrony w terapii. Zamiast tego łączy się narzędzia samoopisowe, obserwacyjne i procesowe. Najważniejsze narzędzia przedstawia poniższa tabela. [33]

| Narzędzie                                                   | Co mierzy                                                                           | Zastosowanie                                                                                            | Ograniczenie                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HSQ</b>                                                  | 4 style humoru: affiliative, self-enhancing, aggressive, self-defeating             | Badania osobowości, dobrostanu, stylów relacyjnych; istnieje dobra polska adaptacja                     | To miara <b>stylu</b> , nie bezpośrednio mechanizmu obronnego w konkretnej sesji |
| <b>DSQ-40</b>                                               | Style obronne: dojrzałe, neurotyczne, niedojrzałe; humor należy do stylu dojrzałego | Samoopisowe badania obron                                                                               | Samoopis obron jest użyteczny, ale nie zastępuje oceny procesowej w sesji        |
| <b>DMRS / DMRS-Q</b>                                        | Obserwowalne mechanizmy obronne i poziom funkcjonowania obronnego                   | Badania procesowe, analiza sesji, monitorowanie zmian                                                   | Wymaga obserwacji/kodowania; bardziej pracochłonne niż kwestionariusze           |
| <b>WAI / WAI-S / WAI-PC</b>                                 | Przymierze terapeutyczne                                                            | Badania nad związkiem humoru z alliance; dostępne także polskie dane walidacyjne dla wersji pacjenckiej | Nie mierzy humoru; trzeba łączyć z innymi narzędziami                            |
| <b>KBI</b>                                                  | Banter/przekomarzanie w sesjach psychoterapii                                       | Badania humoru interpersonalnego w sesji                                                                | Narzędzie nowe i stosunkowo wąskie, skupione na banterze                         |
| <b>Kodowanie epizodów śmiechu + FACS / psychofizjologia</b> | Typy śmiechu, mimika, synchronia, przewodnictwo skórne                              | Badania niewerbalnych funkcji humoru                                                                    | Dobrze opisuje proces, ale słabo oddaje znaczenie subiektywne bez wywiadu        |

**Źródła tabeli:** Hornowska i Charytonik (2011), Andrews i in. (1989), Di Giuseppe i in. (2021), Paap i in. (2022), Prusiński i in. (2021), Brooks i in. (2023), Marci i in. (2004). [33]

Z klinicznego punktu widzenia najlepsza strategia oceny jest **triangulacyjna**: łączyć informację o stylu humoru pacjenta (np. HSQ), jego funkcjonowaniu obronnym (np. DMRS-Q lub uważna analiza sesyjna), jakości alliance (WAI) i konkretnej mikro-sekwencji interakcyjnej w sesji. Właśnie dlatego wiele najciekawszych współczesnych badań łączy obserwację wideo, kodowanie śmiechu i wywiady typu Interpersonal Process Recall. Sam kwestionariusz prawie nigdy nie wystarcza do rozstrzygnięcia, czy dany żart był dojrzałym dystansem, czy obronnym unikaniem (Hoff i Strømme, 2025; Di Giuseppe i in., 2021). [34]

## Implikacje kliniczne i agenda badawcza

Poniższa tabela podsumowuje **praktyczne wskazówki dla klinicystów**. Jest to synteza oparta na danych procesowych, literaturze o alliance i klasycznej teorii obron, a nie formalna rekomendacja towarzystwa naukowego. (Vaillant, 2000; Sarink i García-Montes, 2023; Brooks i in., 2023; Hoff i Strømme, 2025). [35]

| Sytuacja kliniczna                                                                   | Zalecana reakcja                                        | Uzasadnienie                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Humor zwiększa dystans poznawczy, ale pacjent pozostaje w kontakcie z uczuciem       | <b>Zachęcać / współużywać ostrożnie</b>                 | Taki humor zwykle wspiera reappraisal, tolerancję afektu i bond        |
| Humor pojawia się po nazwaniu bólu, nie zamiast niego                                | <b>Wzmacniać refleksyjnie</b>                           | Oznacza raczej dojrzały dystans niż unikanie                           |
| Humor jest życzliwy, włączający i obustronnie zrozumiały                             | <b>Wykorzystywać jako narzędzie alliance</b>            | Sprzyja bezpieczeństwu i zaangażowaniu                                 |
| Pacjent natychmiast żartuje po ujawnieniu wstydu, traumy lub zależności              | <b>Przekierować ku funkcji humoru</b>                   | To częsty wzorzec defensywnego odcięcia od afektu                      |
| Humor ma postać sarkazmu, kpiny, autoupokorzenia albo rekrutuje terapeutę do koluzji | <b>Zatrzymać i nazwać</b>                               | Wysokie ryzyko powielania agresji, wstydu lub pęknięcia przymierza     |
| Terapeuta ma pokusę „rozładowania” własnego dyskomfortu żartem                       | <b>Powstrzymać się i sprawdzić przeciwprzeniesienie</b> | Humor może wtedy służyć bardziej terapeutcie niż pacjentowi            |
| Występuje różnica kulturowa, statusowa lub niepewność co do odbioru żartu            | <b>Zwolnić tempo, sprawdzić odbiór</b>                  | Znaczenie humoru jest silnie zależne od norm kulturowych i relacyjnych |

W praktyce najużyteczniejszym pytaniem nie jest „czy to było zabawne?”, lecz raczej: **„co ten żart zrobił właśnie teraz w relacji i w afekcie?”**. Dobre interwencje kliniczne wokół humoru zwykle zaczynają się od funkcji: „Zauważyłem, że oboje się uśmiechnęliśmy, kiedy temat zrobił się bardzo trudny — jak pan/pani to rozumie?”. Taka mikrointerwencja pozwala odróżnić dojrzały dystans od obronnego uniknięcia i jest spójna zarówno z podejściem psychodynamicznym, jak i z pracą CBT opartą na reappraisal (Dionigi i Canestrari, 2018; Hoff i Strømme, 2025; Perchtold i in., 2019). [36]

Schemat poniżej pokazuje, jak rozwijało się pole badań nad humorem — od klasycznych ujęć psychoanalitycznych do współczesnych badań procesowych i wielopoziomowych. (Vaillant, 2000; Andrews i in., 1989; Martin i in., 2003; Marci i in., 2004; Sarink i García-Montes, 2023; Hoff i Strømme, 2025). [37]



Najważniejsze **luki badawcze** są dziś dość wyraźne. Po pierwsze, potrzeba badań naturalistycznych z **większymi próbami ambulatoryjnymi**, najlepiej wielopoziomowych i sesja-po-sesji. Po drugie, brakuje prac bezpośrednio łączących **style humoru, mechanizmy obronne, alliance i outcome** w jednym modelu. Po trzecie, nadal słabo zbadany jest **humor terapeutyczny**: jego styl osobisty, kontra- i współregulacyjna funkcja oraz warunki bezpieczeństwa etycznego. Po czwarte, potrzeba badań **międzykulturowych i polskojęzycznych**, bo humor jest silnie zależny od norm rozmowy, ironii i granic społecznych. Po piąte, bardzo potrzebne są **badania mechanizmów**, które połączą mikroanalizę dialogu, kodowanie obron, reappraisal i wskaźniki fizjologiczne. Dopiero wtedy będzie można precyzyjnie odpowiedzieć, kiedy humor jest dojrzałą obroną, a kiedy tylko elegancką formą uniku (Sarink i García-Montes, 2023; Goodwin i in., 2024; Hoff i Strømme, 2025). [38]

## Bibliografia

- Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1989). The determination of defense style by questionnaire. *Archives of General Psychiatry*, 46(5), 455–460.
- Bellone, M., Gaffuri, M., & Viallettes, B. (2005). Study on psychiatric disorders and defensive process after failure of artificial insemination. *Annales Médico-Psychologiques*, 163, 290–296.
- Braniecka, A., Parnowska, D., & Radomska, A. (2012). Poczucie humoru u pacjentów z depresją – przegląd badań. *Psychiatria Polska*, 46(6), 1007–1018.
- Brooks, A. B. J., Herrmann, P. L., & Andreas, S. (2021). The use of banter in psychotherapy: A systematic literature review. *Counselling and Psychotherapy Research*, 21, 570–586. doi:10.1002/capr.12361
- Brooks, A. B. J., Baumann, A. W., Huber, D., Rabung, S., & Andreas, S. (2023). Banter in psychotherapy: Relationship to treatment type, therapeutic alliance, and therapy outcome. *Journal of Clinical Psychology*, 79, 1328–1341. doi:10.1002/jclp.23482
- Cai, C., Yu, L., Rong, L., & Zhong, H. (2014). Effectiveness of humor intervention for patients with schizophrenia: A randomized controlled trial. *Journal of Psychiatric Research*, 59, 174–178. doi:10.1016/j.jpsychires.2014.09.010

Despland, J.-N., de Roten, Y., Despars, J., Stigler, M., & Perry, J. C. (2001). Contribution of patient defense mechanisms and therapist interventions to the development of early therapeutic alliance in a brief psychodynamic investigation. *Journal of Psychotherapy Practice and Research*, 10(3), 155–164.

Di Giuseppe, M., Perry, J. C., Lucchesi, M., Michelini, M., Vitiello, S., Piantanida, A., Fabiani, M., Maffei, S., Conversano, C., & Lingardi, V. (2021). The hierarchy of defense mechanisms: Assessing defensive functioning with the Defense Mechanisms Rating Scales Q-Sort. *Frontiers in Psychology*, 12, 718440. doi:10.3389/fpsyg.2021.718440

Dionigi, A., & Canestrari, C. (2018). The use of humor by therapists and clients in cognitive therapy. *The European Journal of Humour Research*, 6(3), 50–67. doi:10.7592/EJHR2018.6.3.dionigi

Dionigi, A., Duradoni, M., & Vagnoli, L. (2023). Humor and attachment: Exploring the relationships between insecure attachment and the comic styles. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 13(1), 161–169.

Falkenberg, I., Buchkremer, G., Bartels, M., & Wild, B. (2011). Implementation of a manual-based training of humor abilities in patients with depression: A pilot study. *Psychiatry Research*, 186(2–3), 454–457. doi:10.1016/j.psychres.2010.10.009

Goodwin, J., O'Malley, M., & McCarthy, K. (2024). How do mental health professionals use humor? A systematic review. *Journal of Creativity in Mental Health*, 19, 673–690. doi:10.1080/15401383.2024.2304605

Gupta, S., Hill, C. E., & Kivlighan, D. M. Jr. (2018). Client laughter in psychodynamic psychotherapy: Not a laughing matter. *Journal of Counseling Psychology*, 65(4), 463–473.

Hall, J. A. (2017). Humor in romantic relationships: A meta-analysis. *Personal Relationships*, 24, 306–322. doi:10.1111/per.12183

Hampes, W. P. (2010). The relation between humor styles and empathy. *Europe's Journal of Psychology*, 6(3), 34–45.

Hoff, C. H., & Strømme, H. (2025). The unbearable lightness of laughing: A reflexive thematic analysis of smiles and laughter in five psychotherapy training processes. *Frontiers in Psychology*, 16, 1720110. doi:10.3389/fpsyg.2025.1720110

Hornowska, E., & Charytonik, J. (2011). Polska adaptacja kwestionariusza stylów humoru (HSQ) R. Martina, P. Puhlik-Doris, G. Larsena, J. Gray i K. Weir. *Studia Psychologiczne*, 49(4), 5–22. doi:10.2478/v10167-010-0032-x

Hussong, D. K., & Micucci, J. A. (2021). The use of humor in psychotherapy: Views of practicing psychotherapists. *Journal of Creativity in Mental Health*, 16(1), 77–94. doi:10.1080/15401383.2020.1760989

Jiang, F., Li, H., & Hou, Y. (2019). Cultural differences in humor perception, usage, and implications. *Frontiers in Psychology, 10*, 123. doi:10.3389/fpsyg.2019.00123

Jiang, F., Lu, S., & Jiang, T. (2020). Does the relation between humor styles and subjective well-being vary across culture and age? A meta-analysis. *Frontiers in Psychology, 11*, 2213. doi:10.3389/fpsyg.2020.02213

Kang, J., et al. (2024). Relationship between client laughter and session outcomes in metaverse counseling. *BMC Psychology*. doi:10.1186/s40359-024-02260-0

Kohn, N., Kellermann, T., Gur, R. C., Schneider, F., & Habel, U. (2011). Gender differences in the neural correlates of humor processing. *Social Cognitive and Affective Neuroscience, 6*(5), 547–555.

Kramer, C. K., et al. (2023). Laughter as medicine: A systematic review and meta-analysis of interventional studies evaluating the impact of spontaneous laughter on cortisol levels. *PLOS ONE, 18*(5), e0285326.

Kubie, L. S. (1970). The destructive potential of humor in psychotherapy. *American Journal of Psychiatry, 127*(7), 861–866.

Kucharski, A. (2023). Positive and negative aspects of employing humour in psychotherapy. *Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 25*(3), 7–16.

Marci, C. D., Moran, E. K., & Orr, S. P. (2004). Physiologic evidence for the interpersonal role of laughter during psychotherapy. *The Journal of Nervous and Mental Disease, 192*(10), 689–695.

Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. *Journal of Research in Personality, 37*(1), 48–75.

Meyer, J. C. (2000). Humor as a double-edged sword: Four functions of humor in communication. *Communication Theory, 10*(3), 310–331.

Mrozowicz-Wrońska, M. (2023). Defense mechanisms in affective disorders – the state of the art. *Psychiatria Polska, 57*(1), 197–206. doi:10.12740/PP/145919

Paap, D., et al. (2022). The Working Alliance Inventory's measurement properties: A systematic review. *Frontiers in Psychology, 13*, 945294.

Panichelli, C., Albert, A., Donneau, A.-F., D'Amore, S., Triffaux, J.-M., & Ansseau, M. (2018). Humor associated with positive outcomes in individual psychotherapy. *American Journal of Psychotherapy, 71*(3), 95–103. doi:10.1176/appi.psychotherapy.20180021

Perchtold, C. M., Weiss, E. M., Rominger, C., Feytaerts, K., Ruch, W., Fink, A., & Papousek, I. (2019). Humorous cognitive reappraisal: More benign humour and less “dark” humour is affiliated with more adaptive cognitive reappraisal strategies. *PLOS ONE, 14*(1), e0211618. doi:10.1371/journal.pone.0211618



Prusiński, T., et al. (2021). Validity of the Working Alliance Inventory (patient version) in adult systemic psychotherapy. *Polish Psychological Bulletin*.

Samson, A. C., Glassco, A. L., Lee, I. A., & Gross, J. J. (2014). Humorous coping and serious reappraisal: Short-term and longer-term effects. *Europe's Journal of Psychology*, 10(3), 571–581. doi:10.5964/ejop.v10i3.730

Sarink, F. S. M., & García-Montes, J. M. (2023). Humor interventions in psychotherapy and their effect on levels of depression and anxiety in adult clients: A systematic review. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 1049476. doi:10.3389/fpsyt.2022.1049476

Schneider, M., Voracek, M., & Tran, U. S. (2018). “A joke a day keeps the doctor away?” Meta-analytical evidence of differential associations of habitual humor styles with mental health. *Scandinavian Journal of Psychology*, 59(3), 289–300. doi:10.1111/sjop.12432

Vaillant, G. E. (2000). Adaptive mental mechanisms: Their role in a positive psychology. *American Psychologist*, 55(1), 89–98. doi:10.1037/0003-066X.55.1.89

Winterheld, H. A., & Simpson, J. A. (2013). Attachment and the dyadic nature of humor during conflict discussions in romantic couples. *Personal Relationships*, 20(4), 664–682.

---

[1] [7] [15] [18] [19] [35] [37] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11392869/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11392869/>

[2] [5] [9] [21] [22] [26] [38]  
<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2022.1049476/full>

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2022.1049476/full>

[3] [23] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15457112/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15457112/>

[4] [31] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9845902/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9845902/>

[6] [11] <https://academic.oup.com/ct/article-abstract/10/3/310/4201747>

<https://academic.oup.com/ct/article-abstract/10/3/310/4201747>

[8] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16389709/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16389709/>

[10] [24]  
[https://www.researchgate.net/publication/271348284\\_Humorous\\_Coping\\_and\\_Serious\\_Reappraisal\\_Short-Term\\_and\\_Longer-Term\\_Effects](https://www.researchgate.net/publication/271348284_Humorous_Coping_and_Serious_Reappraisal_Short-Term_and_Longer-Term_Effects)

[https://www.researchgate.net/publication/271348284\\_Humorous\\_Coping\\_and\\_Serious\\_Reappraisal\\_Short-Term\\_and\\_Longer-Term\\_Effects](https://www.researchgate.net/publication/271348284_Humorous_Coping_and_Serious_Reappraisal_Short-Term_and_Longer-Term_Effects)

[12] [25] [36] <https://europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/view/292>

<https://europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/view/292>

[13] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120675/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120675/>

[14] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21320516/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21320516/>

[16] [29] [33] <https://journals.pan.pl/Content/95030>

<https://journals.pan.pl/Content/95030>

[17] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29431190/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29431190/>

[20] [27] [https://www.researchgate.net/publication/314634799\\_Humor\\_in\\_romantic\\_relationships\\_A\\_meta-analysis\\_Humor\\_meta-analysis](https://www.researchgate.net/publication/314634799_Humor_in_romantic_relationships_A_meta-analysis_Humor_meta-analysis)

[https://www.researchgate.net/publication/314634799\\_Humor\\_in\\_romantic\\_relationships\\_A\\_meta-analysis\\_Humor\\_meta-analysis](https://www.researchgate.net/publication/314634799_Humor_in_romantic_relationships_A_meta-analysis_Humor_meta-analysis)

[28] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30761053/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30761053/>

[30] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9857711/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9857711/>

[32] <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15401383.2024.2304605>

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15401383.2024.2304605>

[34] <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1720110/full>

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1720110/full>